Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Tonsillektomi

Bademcik ameliyatı (tamamen veya kısmen alınması)

Değerli hastamız, bu form size önerilen işlem hakkında bilmeniz gerekenleri **sade ve anlaşılır** bir dille anlatmak için hazırlanmıştır. Amacı sizi korkutmak değil, kararınızı **bilgiye dayanarak ve özgürce** vermenize yardımcı olmaktır.

Formu acele etmeden okuyunuz. Anlamadığınız her noktayı hekiminize sorunuz. Hekiminiz sizin durumunuza özel riskleri ayrıca sözlü olarak da açıklayacaktır. Onay vermek ya da vermemek tamamen sizin hakkınızdır.

HASTA VE İŞLEM BİLGİLERİ

Adı Soyadı: _____ Doğum tarihi: _____

T.C. Kimlik / Pasaport: _____ Dosya / Protokol No: _____

Telefon: _____ Bilgilendirme tarihi: _____

Planlanan işlem tarihi: _____

Form hastaya ilk iletildi (tarih / e-posta, WhatsApp, elden): _____

İşlemi yapacak ve bilgilendiren hekim: **Op. Dr. Murat Ayata**

İşlemin yapılacağı sağlık kuruluşu: _____

Planlanan teknik: ☐ Soğuk diseksiyon ☐ Koter (elektrokoter) ☐ Radyofrekans / koblasyon ☐ Tonsillotomi (kısmi alma)

Aynı seansta yapılacak ek işlemler: ☐ Adenoidektomi ☐ Ventilasyon tüpü ☐ Yok _____

Ameliyat endikasyonu (hekim tarafından): ☐ Tekrarlayan bademcik iltihabı ☐ Uykuda solunum bozukluğu / horlama ☐ Bademcik çevresi apsesi ☐ Tek taraflı büyüme / doku tanısı _____

Diğer / açıklama: _____

1 Durumunuz ve işlemin amacı

Bademcikler (tonsiller), boğazın iki yanında, dil kökünün üzerinde yer alan ve vücudun savunma sistemine ait lenf dokusudur. Bademcikler alındığında vücudun savunma sistemi, ağız ve boğazdaki diğer lenf dokuları sayesinde çalışmaya devam eder; ameliyatın bağışıklığı zayıflattığı gösterilmemiştir.

Bademcik ameliyatı en sık şu nedenlerle önerilir: yılda birçok kez tekrarlayan ve okul/iş kaybına neden olan **bademcik iltihapları**; bademciklerin büyüyerek **horlama ve uykuda nefes durmalarına** yol açması; **bademcik çevresinde apse** gelişmesi; bademcikte tek taraflı büyüme veya şüpheli bir doku değişikliği olması. Bazı hastalarda ağız kokusu ve bademcik taşları da nedenler arasında olabilir.

Ameliyatın amacı bu şikâyetleri ortadan kaldırmak veya azaltmaktır. Size veya çocuğunuza ameliyatın neden önerildiği, hekiminiz tarafından ayrıca açıklanacaktır.

2 İşlem nasıl yapılır?

Ameliyat genel anestezi altında, ameliyathane koşullarında, ağız içinden yapılır; **dışarıda kesi veya iz yoktur.**

1. **Hazırlık:** Anestezi verildikten sonra ağzı açık tutan ve dili koruyan özel bir alet yerleştirilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2. **Bademciklerin çıkarılması:** Bademcik, çevresindeki kapsülle birlikte altındaki kas tabakasından ayrılarak çıkarılır. Bu işlem planlanan tekniğe göre makas ve diseksiyon aletleri (soğuk diseksiyon), elektrokoter veya radyofrekans/koblasyon cihazları ile yapılır.
3. **Kısmi alma (tonsillotomi):** Uygun hastalarda, özellikle uyku sırasında solunum sorunu yaşayan küçük çocuklarda, bademciğin yalnızca büyümüş kısmı alınıp ince bir tabaka bırakılabilir. Bu yöntemde ağrı ve kanama riski daha düşük olabilir; ancak kalan dokunun yeniden büyümesi veya iltihaplanması mümkündür.
4. **Kanama kontrolü:** Bademcik yatağındaki kanamalar dikiş, bağlama veya koter ile dikkatle durdurulur. Bademcik yatağı genellikle açık bırakılır ve kendiliğinden iyileşir.
5. **Ek işlemler:** Planlandıysa aynı anestezi sırasında geniz eti ameliyatı (adenoidektomi) veya kulak tüpü uygulaması yapılır; bu işlemler için ayrı onam formları doldurulur.
6. **Uyanma ve gözlem:** Ameliyat sonrası hasta derlenme odasında, ardından serviste kanama, solunum ve sıvı alımı açısından izlenir.

Çıkarılan bademcikler, hekim gerekli görürse patolojik incelemeye gönderilir.

ANESTEZİ	TAHMİNİ SÜRE	HASTANEDE KALIŞ / TABURCULUK
Genel anestezi	Yaklaşık 30–45 dakika (anestezi süresi hariç)	Genellikle 1 gece hastanede gözlem

3 Beklenen faydalar ve başarı şansı

- Tekrarlayan bademcik iltihaplarının, buna bağlı ateş, boğaz ağrısı, antibiyotik kullanımı ve okul/iş kaybının belirgin şekilde azalması
- Horlama ve uykuda nefes durmalarının azalması; daha kaliteli uyku, gündüz dikkat ve davranışta düzelme
- Bademcik çevresi apsesinin tekrarlamasının önlenmesi
- Gerekli durumlarda dokunun patolojik incelemesiyle kesin tanı konulması

Uygun seçilmiş hastalarda tekrarlayan boğaz enfeksiyonları ve uykuda solunum bozuklukları büyük oranda düzelir. Ameliyattan sonra da zaman zaman boğaz enfeksiyonu (farenjit) geçirilebilir, ancak bunlar genellikle daha seyrek ve daha hafiftir. Uyku apnesinin kilo fazlalığı, yüz yapısı veya burun tıkanıklığı gibi başka nedenleri de varsa şikâyetler tamamen geçmeyebilir ve ek tedavi gerekebilir.

4 Diğer tedavi seçenekleri

- **Bekle-gör (izlem):** İltihap sıklığı ameliyat ölçütlerini karşılamıyorsa veya şikâyetler hafifse, düzenli kontrolle beklemek uygun olabilir. Çocuklarda bademcik iltihaplarının sıklığı yaşla azalabilir.
- **Antibiyotik ve destek tedavisi:** Her enfeksiyon atağında ilaçla tedavi edilmeye devam edilir; enfeksiyonların tekrarlamasını önlemez.
- **Kısmi alma (tonsillotomi):** Uygun hastalarda tam alma yerine düşünülebilir (yukarıda açıklanmıştır).
- **Uyku apnesinde diğer seçenekler:** Kilo verme, burun tıkanıklığının tedavisi, kortizonlu burun spreyleri veya uyku sırasında pozitif basınçlı solunum cihazı (CPAP) kullanımı.

5 İşlem yapılmazsa ne olur?

Ameliyat yapılmazsa tekrarlayan bademcik iltihapları, ateş, antibiyotik kullanımı ve okul/iş kaybı devam edebilir. Nadiren bademcik çevresinde apse gelişebilir veya iltihap boyun dokularına yayılabilir. Bademcik büyüklüğüne bağlı uyku apnesi tedavi edilmezse, özellikle çocuklarda büyüme-gelişme geriliği, dikkat ve davranış sorunları, gece altını ıslatma ve uzun dönemde kalp-akciğer üzerinde yük oluşabilir. Tek taraflı büyüme gibi şüpheli durumlarda ameliyatın yapılmaması kesin tanının gecikmesine neden olabilir.

Önerilen işlemi kabul etmeme, ertelemek isteme veya ikinci bir hekim görüşü alma hakkınız vardır. Bu kararınız, size sunulan diğer sağlık hizmetlerini hiçbir şekilde olumsuz etkilemez. Verdiğiniz onayı, işlem başlamadan önce istediğiniz zaman geri alabilirsiniz; ancak işlem başladıktan sonra tıbben durdurulması sakıncalı olabilecek aşamalar olabileceğini de bilmenizi isteriz.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

6 İşlem öncesi hazırlık

- Ameliyattan önce kan tahlilleri (özellikle kanama-pıhtılaşma testleri) ve gerekirse diğer tetkikler yapılır; anestezi uzmanı tarafından değerlendirilirsiniz.
- Sizde veya ailenizde kolay kanama, sık burun kanaması, uzun süren adet kanaması, diş çekiminden sonra durmayan kanama veya bilinen bir kanama bozukluğu varsa mutlaka bildiriniz.
- Ameliyattan önceki **6 saat** boyunca katı gıda ve süt alınmamalıdır; berrak sıvılar için anestezi uzmanının vereceği süreye uyunuz.
- Ameliyattan önceki 2–3 hafta içinde aktif bademcik iltihabı, ateşli hastalık veya grip geçirilirse bildiriniz; ameliyatın ertelenmesi gerekebilir.
- Sallanan diş veya diş protezi varsa hekiminize söyleyiniz.
- Yurt dışından geliyorsanız, ameliyat sonrası **en az 10–14 gün** hekime ve hastaneye ulaşılabilecek bir yerde kalmanızı öneririz (geç kanama riski nedeniyle).
- Kullandığınız **tüm ilaçları** (kan sulandırıcılar, aspirin, ağrı kesiciler, kilo verme ilaçları, hormon ilaçları dahil), **bitkisel ürünleri ve takviyeleri** (omega-3, E vitamini, ginkgo, sarımsak, ginseng, balık yağı gibi) hekiminize bildiriniz. Hekiminizin onayı olmadan kendi kendinize hiçbir ilacı kesmeyiniz.
- Bilinen **alerjilerinizi**, kanama veya pıhtılaşma sorunlarınızı, kalp, akciğer, şeker, tansiyon, tiroid gibi hastalıklarınızı, daha önce geçirdiğiniz ameliyatları ve anesteziyle ilgili sorunları mutlaka belirtiniz.
- Hamilelik ihtimaliniz varsa veya emziriyorsanız işlemden önce mutlaka söyleyiniz.
- Sigara ve nikotin ürünleri yara iyileşmesini belirgin şekilde bozar. Mümkünse işlemden en az 2–4 hafta önce bırakmanız ve iyileşme süresince içmemeniz önerilir.

7 İyileşme süreci: sizi neler bekliyor?

Ameliyat günü	Uyandıktan sonra boğaz ağrısı olur ve ağrı kesicilerle kontrol edilir. Bulantı geçtikten sonra su, ardından soğuk-ılık sıvılar ve yumuşak gıdalar verilir. Gece hastanede kanama, solunum ve sıvı alımı açısından izlenirsiniz.
1–4. günler	Boğaz ağrısı ve kulağa vuran ağrı belirgindir. Bademcik yataklarında **beyaz-sarımsı bir tabaka** oluşur; bu iyileşmenin normal parçasıdır, iltihap değildir. Ağız kokusu ve hafif ateş olabilir. **Düzenli ağrı kesici kullanmak ve bol sıvı içmek** en önemli noktadır.
5–10. günler	Beyaz tabaka dökülmeye başlar. Ağrı bazen bu dönemde yeniden artabilir. **Geç kanama riskinin en yüksek olduğu dönemdir**; bu nedenle ağır egzersiz, sıcak banyo/sauna ve sert gıdalardan kaçınılmalı, kanama belirtilerinde hemen başvurulmalıdır.
10–14. günler	Ağrı belirgin şekilde azalır, normal beslenmeye geçilir. Çoğu çocuk okula, yetişkinler işe 10–14 gün içinde dönebilir. Spor ve ağır fiziksel aktivite yaklaşık 2–3 hafta sonra serbesttir.
3–6. haftalar	Bademcik yatakları tamamen iyileşir. Kontrol muayenesi yapılır; patolojik inceleme yapıldıysa sonucu değerlendirilir.

8 Olası riskler ve komplikasyonlar

Her tıbbi işlemde olduğu gibi bu işlemin de bazı riskleri vardır. Aşağıda **beklenen geçici etkiler** ile **komplikasyonlar** ayrı ayrı ve görülme sıklıklarına göre gruplandırılmıştır. Verilen oranlar bilimsel yayınlara dayanan **yaklaşık** değerlerdir; sizin kişisel riskiniz yaşınıza, genel sağlığınıza, sigara kullanımına ve daha önce geçirdiğiniz ameliyatlara göre daha düşük ya da daha yüksek olabilir.

Komplikasyonların büyük çoğunluğu **geçicidir** ve uygun tedaviyle düzelir. Listede çok nadir görülen ciddi durumlara da yer verilmiştir; bunların yazılmış olması sizde görüleceği anlamına gelmez, ancak bilgilenmiş karar verebilmeniz için bilmeniz gerekir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Beklenen, geçici etkiler (komplikasyon sayılmaz; iyileşmenin doğal parçasıdır)

- Boğaz ağrısı (genellikle 7–14 gün sürer; yetişkinlerde çocuklara göre daha fazladır)
- Kulağa vuran ağrı (yansıyan ağrı; kulakta bir hastalık olduğu anlamına gelmez)
- Yutkunma güçlüğü ve iştahsızlık; ilk günlerde kilo kaybı
- Bademcik yataklarında beyaz-sarı iyileşme tabakası ve ağız kokusu
- Hafif ateş (ilk günler), anesteziye bağlı bulantı-kusma
- Dil ve küçük dilde (uvula) geçici şişlik

Sık görülen durumlar (çoğu geçicidir veya tedaviyle düzelir)

- **Ameliyat sonrası kanama (geç kanama)** — Yaklaşık 100 hastadan **2–5'inde** görülür; çoğunlukla **ameliyattan sonraki 5–10. günlerde**, iyileşme tabakası dökülürken ortaya çıkar. Yetişkinlerde çocuklara göre biraz daha sıktır. Kanamaların çoğu küçüktür ve gözlem, buz, ağız içi tedavi veya basit müdahaleyle durur.
- **Kanama nedeniyle yeniden ameliyat** — Yaklaşık 100 hastadan **1–3'ünde** kanamanın durdurulması için **yeniden genel anestezi altında ameliyathaneye** girilmesi gerekebilir. Hastanede yatış süresi uzayabilir.
- **Sıvı alamama ve sıvı kaybı (dehidratasyon)** — Ağrı nedeniyle yeterli sıvı alınmazsa, özellikle küçük çocuklarda halsizlik ve idrar azalması olabilir; bazen damar yoluyla serum verilmesi için hastaneye yatış gerekebilir.

Seyrek görülen durumlar

- **Kan nakli** — Kanama sırasında kan kaybı fazlaysa kan nakli gerekebilir; bu durum **100 hastada 1'den çok daha azdır**.
- **Tat değişikliği ve dilde uyuşukluk** — Ameliyat sırasında dilin aletle baskı altında kalmasına bağlı olarak tat almada değişiklik veya dilde uyuşma olabilir; genellikle birkaç hafta içinde düzelir, nadiren aylarca sürebilir veya kalıcı olabilir.
- **Diş, dudak ve dil yaralanmaları** — Ağzı açık tutan aletin baskısıyla dişte kırılma (özellikle sallanan veya çürük dişlerde), dudakta veya dilde küçük yanık, yara ya da şişlik oluşabilir.
- **Enfeksiyon** — Bademcik yatağında veya boyunda enfeksiyon gelişebilir; genellikle antibiyotikle tedavi edilir.
- **Geçici genizden konuşma** — Damağın hareketinin ağrı nedeniyle kısıtlanmasına bağlı olarak ses geçici olarak burundan kaçabilir; genellikle birkaç haftada düzelir.
- **Tonsillotomi sonrası yeniden büyüme** — Kısmi alma yapıldıysa kalan bademcik dokusu yeniden büyüyebilir veya iltihaplanabilir (100 hastada yaklaşık **1–6**); nadiren tam alma ameliyatı gerekebilir.

Nadir veya çok nadir, ancak ciddi olabilecek durumlar

- **Ciddi kanama ve sonuçları** — Nadiren kanama ağır ve hızlı olabilir. Bu durumda **acil ameliyat, kan nakli** ve çok nadiren boyundaki damarlara yönelik ek girişimler gerekebilir. Ağır kan kaybı ya da kanın solunum yoluna kaçması **solunum yetmezliği, yoğun bakımda tedavi ihtiyacı** ve buna bağlı kalıcı hasar gibi ciddi sonuçlara yol açabilir.
- **Hayatı tehdit eden komplikasyonlar ve ölüm** — Bademcik ameliyatına bağlı ölüm son derece nadirdir; bilimsel kaynaklarda yaklaşık **15.000–35.000 ameliyatta 1** olarak bildirilmektedir. En sık nedenleri ağır kanama ve solunum sorunlarıdır. Ağır uyku apnesi olan küçük çocuklarda ameliyat sonrası solunum sorunları riski daha yüksektir; bu nedenle bu hastalar daha yakından izlenir.
- **Kalıcı genizden konuşma / sıvıların burundan gelmesi (velofaringeal yetmezlik)** — Çok nadirdir; daha çok gizli damak yarığı olanlarda görülür. Konuşma terapisi veya nadiren düzeltici ameliyat gerekebilir.
- **Boyun omurlarında kayma (Grisel sendromu), boyun ve göğüs boşluğuna yayılan enfeksiyon** — Çok nadir görülen, erken fark edildiğinde tedavi edilebilen durumlardır. Giderek artan boyun ağrısı, başı çevirememe, yüksek ateş ve yutkunamama ile kendini gösterebilir. Gelişirse hastanede yatış, damar yoluyla antibiyotik ve gerekirse cerrahi drenaj gerekir; tedavi gecikirse kalıcı boyun sorunları gelişebilir veya yayılan enfeksiyon hayatı tehdit edebilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Yutak ve damakta yara izi, daralma** — Çok nadiren iyileşme sırasında aşırı iz dokusu gelişerek yutak veya damakta daralmaya, yutma ve konuşma güçlüğüne yol açabilir.
- **Çene ekleminde ağrı veya çıkık** — Ağzın uzun süre açık tutulmasına bağlı olarak çok nadiren görülür.

Her cerrahi / tıbbi girişim için geçerli genel riskler

- **Anestezi riskleri:** Genel anestezi veya sedasyon uygulanacaksa riskleri (bulantı, boğaz ağrısı, diş hasarı, alerjik reaksiyon, çok nadiren kalp-akciğer sorunları) anestezi uzmanı tarafından ayrıca anlatılır ve **ayrı bir anestezi onam formu** ile onayınız alınır.
- **Kanama ve kan nakli:** Bu işlemlerde kan nakli ihtiyacı çok nadirdir. Ciddi bir kanamada kan veya kan ürünü verilmesi gerekebilir; bunun da kendine özgü (alerji, enfeksiyon gibi) çok nadir riskleri vardır.
- **Enfeksiyon:** Ameliyat sonrası yara enfeksiyonu genellikle antibiyotikle tedavi edilir; nadiren drenaj (iltihabın boşaltılması) gerekebilir.
- **Bacak toplardamarlarında pıhtı (DVT) ve akciğere pıhtı atması (pulmoner emboli):** Kısa süren baş-boyun ameliyatlarında çok nadirdir. Erken hareket etmek riski azaltır. Hormon ilacı kullanımı, sigara, obezite ve önceki pıhtı öyküsü riski artırır.
- **İlaç alerjisi:** Kullanılan ilaçlara, antiseptiklere, banda veya dikiş materyaline karşı alerjik reaksiyon gelişebilir.
- **Yara izi ve iyileşme sorunları:** Kişiden kişiye değişen iz oluşumu; çok nadiren kalın (hipertrofik) iz veya keloid gelişebilir.
- **Hayati risk:** Günümüzde planlı baş-boyun cerrahisinde ölüm son derece nadirdir; ancak hiçbir cerrahi girişimin riski tamamen sıfır değildir. Ciddi bir komplikasyon hâlinde yoğun bakım tedavisi gerekebilir ve kalıcı sakatlık gelişebilir.

Bu liste mümkün olan tüm komplikasyonları kapsamaz; tıpta öngörülemeyen, çok nadir başka durumlar da ortaya çıkabilir. Bir komplikasyon gelişirse, gerekli tedavi ve takip hekiminiz tarafından planlanır; bu durum ek tedavi, ilaç, girişim veya yeniden ameliyat gerektirebilir.

9 Hemen bize ulaşmanız gereken durumlar

- Ağızdan **taze, kırmızı kan** gelmesi, kan tükürme veya kan kusma — **birkaç damla bile olsa** bekletmeden başvurunuz. Kanama varsa başınızı öne eğerek kanı yutmayınız, tükürünüz; soğuk su ile gargara yapabilirsiniz.
- Çocuklarda **sık sık yutkunma**, solukluk, halsizlik, uykudan uyanmakta güçlük (yutulan kanın işareti olabilir)
- **Nefes almada zorluk**, uykuda belirgin nefes durması, hırıltılı solunum
- **38,5 °C üzerinde ateş**, ağrı kesicilere rağmen geçmeyen veya giderek artan ağrı
- Hiç sıvı içmeme, 8 saattir idrar yapmama, aşırı uykuya meyil (sıvı kaybı belirtileri)
- Giderek artan boyun ağrısı, başı çevirememe, boyunda şişlik

Bu durumlardan biri olursa bekletmeden hekiminizi arayınız: 0288 502 50 20 · WhatsApp 0555 333 21 20. Ulaşamazsanız en yakın acil servise başvurunuz veya 112'yi arayınız.

10 İlaçlar ve günlük yaşam ile ilgili öneriler

- Ağrı için yalnızca **hekiminizin önerdiği ağrı kesicileri**, önerilen doz ve aralıklarla, **düzenli olarak** kullanınız. Aspirin ve hekiminizin önermediği diğer ağrı kesiciler kanama riskini artırabilir; kendi kendinize ilaç eklemeyiniz.
- **Bol sıvı tüketmek** en önemli kuraldır. Soğuk-ılık su, ayran, komposto, dondurma, muhallebi, yoğurt, püre gibi yumuşak gıdalar uygundur. Çok sıcak, asitli, baharatlı ve sert/kıtır gıdalardan (cips, kraker, kızarmış ekmek) yaklaşık **2 hafta** kaçınınız.
- İlk 2 hafta ağır egzersiz, sıcak banyo, sauna ve güneşte uzun süre kalmaktan kaçınınız.
- Diş fırçalamaya devam edebilirsiniz; boğaz bölgesine sert temas etmeyiniz.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Yurt dışına dönüş uçuşunu, geç kanama riski geçene kadar (genellikle **ameliyat sonrası 10–14. gün**) ertelemeniz önerilir. Bu süreden önce uçmanız gerekirse riskleri hekiminizle konuşunuz.
- Size reçete edilen ilaçları (antibiyotik, ağrı kesici vb.) önerilen doz ve sürede kullanınız. Aspirin ve benzeri kanamayı artırabilecek ilaçları hekiminize danışmadan kullanmayınız.
- Ameliyat sonrası 4 saatten uzun uçak veya kara yolculuğunda bol su için, sık sık hareket edin ve önerildiyse varis çorabı kullanın; bu, bacakta pıhtı riskini azaltır.
- İyileşme sürecinde alkol almamanız, sigara ve nikotin ürünlerinden uzak durmanız önerilir.
- Kontrol randevularınıza mutlaka geliniz. Yurt dışından geldiyseniz dönüşünüzden sonra kontroller online görüşme ve fotoğraf/video ile sürdürülebilir; yerel bir hekime başvurmanız gerekirse size ameliyat raporu ve önerilerimiz yazılı olarak verilir.

11 İşlem sırasında beklenmeyen durumlar, doku örnekleri ve kan ürünleri

İşlem sırasında önceden öngörülemeyen bir durumla karşılaşılırsa, hekiminiz yalnızca bu formda onay verdiğiniz işlemin kapsamında kalır. **Hayati tehlike veya ciddi organ zararı riski** olmadıkça onay vermediğiniz ek bir işlem yapılmaz; böyle bir durumda işlem uygun noktada sonlandırılır ve size sonradan bilgi verilerek karar birlikte alınır. Hayati tehlike durumunda ise hayatınızı veya organınızı korumak için gerekli acil müdahale yapılır.

İşlem sırasında çıkarılan dokular, gerekli görüldüğünde tanının kesinleştirilmesi için **patolojik incelemeye** gönderilir. Bu inceleme sonucuna göre ek tedavi veya takip gerekebilir.

Kan nakli ihtiyacı bu işlemlerde çok nadirdir; yalnızca hayati gerekliliği olan durumlarda uygulanır. Kan veya kan ürünü almayı kabul etmiyorsanız (örneğin inanç nedeniyle) bunu işlemden önce mutlaka bildiriniz; bu kararın olası sonuçları sizinle ayrıca konuşulur ve "Size özel bilgiler" bölümüne yazılır.

12 Fotoğraf, görüntü kayıtları ve kişisel verileriniz

Tedavinizin planlanması, takibi ve sonucun değerlendirilmesi amacıyla işlem öncesinde ve sonrasında **fotoğraf/video** çekilebilir. Bu kayıtlar sağlık dosyanızın parçasıdır ve gizli tutulur. Görüntüleriniz **hiçbir koşulda reklam, tanıtım veya sosyal medya amacıyla kullanılmaz.**

Görüntülerinizin bunun dışındaki amaçlarla kullanılması **yalnızca sizin ayrı ve açık izninizle** mümkündür. İzin vermemeniz tedavinizi hiçbir şekilde etkilemez ve verdiğiniz izni dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz:

☐ Görüntülerimin yalnızca **tıbbi kayıt ve tedavi takibi** amacıyla kullanılmasını kabul ediyorum.

☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılmayacak şekilde** (yüz/göz bölgesi kapatılarak) bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.

☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılabilecek şekilde** bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.

☐ Bilimsel/eğitim amaçlı kullanıma **izin vermiyorum.**

Kişisel ve sağlık verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sağlık mevzuatı kapsamında, tanı, tedavi ve yasal yükümlülükler amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altındaki kişilerce işlenir. Ayrıntılı bilgi için KVKK Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

13 Size özel bilgiler ve notlar (hekim tarafından doldurulur)

Hastaya özgü ek riskler (eşlik eden hastalıklar, kullanılan ilaçlar, önceki ameliyatlar), planın ayrıntıları, hastanın beklentisi, sorduğu sorular ve verilen cevaplar. Boş kalacaksa "yoktur" yazılır.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

14 Hasta beyanı

- ☐ Bu formu kendi dilimde okudum, anladım. Yeterli düşünme süresi tanındı; sorularımı sorma fırsatı buldum ve tatmin edici yanıtlar aldım.
- ☐ Durumum, önerilen işlemin amacı, nasıl yapılacağı, kim tarafından ve nerede yapılacağı, tahmini süresi, beklenen faydaları, başarı şansı, alternatifleri ve işlem yapılmazsa olabilecekler bana sözlü ve yazılı olarak açıklandı.
- ☐ Sık görülen ve ciddi olabilecek riskler ile bu komplikasyonların olası sonuçları (ek tedavi, yeniden işlem/ameliyat gerekebileceği dahil) bana anlatıldı. Tıpta hiçbir işlemin sonucunun **%100 garanti edilemeyeceğini** biliyorum.
- ☐ Sağlık durumum, kullandığım ilaçlar, alerjilerim ve geçirdiğim hastalıklar hakkında doğru ve eksiksiz bilgi verdim. Eksik veya yanlış bilgi vermemin riskleri artırabileceğini biliyorum.
- ☐ İşlem öncesi ve sonrasında verilecek talimatlara uymamın sonucun bir parçası olduğunu ve kontrol randevularına gelmenin önemini anladım.
- ☐ Onayımı işlem başlamadan önce istediğim zaman geri alabileceğimi biliyorum. Bu formu imzalamamın, hekimin özen yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını biliyorum.
- ☐ Bu kararı kimsenin baskısı olmadan, kendi özgür irademle veriyorum.
- ☐ Ameliyattan sonraki ilk 2 hafta içinde, özellikle 5–10. günlerde **geç kanama olabileceği**, bu durumda bekletmeden hekime veya en yakın acil servise başvurmam gerektiği ve kanamanın yeniden ameliyat, kan nakli ve nadiren yoğun bakım tedavisi gerektirebileceği bana açıkça anlatıldı.

- ☐ **Yukarıda açıklanan işlemin bana uygulanmasına ONAY VERİYORUM.**
- ☐ **Yukarıda açıklanan işlemi KABUL ETMİYORUM. Reddetmenin olası sonuçları bana anlatıldı.**

Hasta tarafından kendi el yazısıyla yazılması önerilir: "Bu formu okudum, anladım, onay veriyorum."

15 İmzalar

	ADI SOYADI	İMZA	TARİH / SAAT
Hasta			
Yasal temsilci (veli / vasi) — yakınlığı:			
Bilgilendiren ve işlemi yapacak hekim			
Tercüman (gerekirse) — dil:			
Tanık (gerekirse)			

Tercüman beyanı: Bu formu ve hekimin sözlü açıklamalarını hastaya / yasal temsilciye eksiksiz ve doğru olarak, anladığı dilde tercüme ettim.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

18 YAŞINDAN KÜÇÜK VEYA KARAR VERME YETİSİ KISITLI HASTALAR İÇİN

18 yaşından küçük hastalarda onam, **veli veya vasi** tarafından verilir. Çocuk, yaşı ve olgunluğuyla uyumlu biçimde bilgilendirilir ve görüşü alınır. Kısıtlı hastalarda onamı yasal temsilci verir.

☐ Velayeti birlikte kullanıyorsak, diğer ebeveynin de bu işlemden haberdar olduğunu ve onay verdiğini beyan ederim.

☐ Velayet / vesayet konusunda bir mahkeme kararı veya anlaşmazlık bulunmadığını beyan ederim (varsa hekime belgesi gösterilmiştir).

Çocuğun yaşına uygun şekilde bilgilendirildiği ve görüşü: _____

Bu form iki nüsha olarak düzenlenmiştir: bir nüshası hasta dosyasında saklanır, bir nüshası hastaya / yasal temsilciye verilir.

ONAMIN GERİ ALINMASI (YALNIZCA VAZGEÇİLMESİ HÂLİNDE DOLDURULUR)

Yukarıda verdiğim onayı geri alıyorum. Vazgeçmemin olası sonuçları bana açıklandı.

Vazgeçen hasta/temsilci adı soyadı, imza, tarih, saat: _____

Bu form, T.C. Hasta Hakları Yönetmeliği ve Türk Tabipleri Birliği Aydınlatılmış Onam ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Sözlü bilgilendirmenin yerini tutmaz, onu tamamlar.